

Antibioprophylaxie — Champ 1 (recommandations générales)

Introduction, méthodologie, périmètre & légende



Champ : antibioprophylaxie (prévention médicamenteuse de l'infection du site opératoire, ISO) en chirurgie et médecine interventionnelle — patients adultes et pédiatriques, chirurgies propres et propres-contaminées (classes 1-2 d'Altemeier). RFE de la SFAR et de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF), en association avec 32 sociétés savantes de chirurgie et médecine interventionnelle. V3.0 du 04/05/2026 (V1.0 originale du 08/12/2023 ; Champ 3 pédiatrique ajouté en V3.0).

Méthodologie : méthode GRADE® — analyse qualitative et quantitative de la littérature (recherche bibliographique MEDLINE/Cochrane/clinicaltrials.gov, janvier 2000 à mars 2023, méthodologie PRISMA), cotation collective par grille GRADE Grid (validation à $\geq 70\%$ d'opinions convergentes et $< 20\%$ d'opinions contraires). Un seul critère de jugement « majeur » : l'infection du site opératoire.

Périmètre de cette fiche — partiel, disclosure explicite : le document source traite **3 champs** : **Champ 1** — 11 recommandations générales, applicables à toute procédure quelle que soit la discipline (objet intégral de cette fiche) ; **Champ 2** — 9 tableaux disciplinaires **adultes** (neurochirurgie/neuroradiologie interventionnelle ; ORL/ophtalmologie/chirurgie maxillo-faciale ; chirurgie cardiaque/cardiologie interventionnelle/rythmologie/chirurgie vasculaire ; chirurgie thoracique/endoscopie thoracique/radiologie interventionnelle ; chirurgie plastique et reconstructrice/d'affirmation de genre/du patient brûlé ; chirurgie gynécologique et obstétrique ; chirurgie orthopédique et traumatologique ; chirurgie digestive et bariatrique/endoscopie et médecine interventionnelle digestive ; chirurgie urologique) ; **Champ 3** — 9 tableaux disciplinaires **pédiatriques et néonataux**, reprenant globalement les mêmes disciplines que le Champ 2, à deux différences près : la chirurgie gynécologique et obstétrique du Champ 2 n'a **pas** de tableau pédiatrique dédié, remplacée par un tableau spécifique de **chirurgie néonatalogique**. Les Champs 2 et 3 sont des **tableaux de posologie par procédure** (molécule, dose, voie, délai de réinjection), consultés au cas par cas au bloc opératoire — ils totalisent environ 85 pages et ne se prêtent pas à une fiche de synthèse narrative unique. **Cette fiche ne couvre donc PAS les Champs 2 et 3** : pour le choix et la posologie de l'antibioprophylaxie d'une procédure donnée, se référer directement au tableau disciplinaire correspondant dans le texte intégral.

Légende (grades GRADE de la source)

GRADE 1 Niveau de preuve global « fort » — recommandation forte (« il est recommandé de... » / « il n'est pas recommandé de... »).

GRADE 2 Niveau de preuve global modéré ou faible — recommandation optionnelle (« il est probablement recommandé de... » / « il n'est probablement pas recommandé de... »).

AE Avis d'experts — littérature insuffisante pour graduer ; consensus formalisé du groupe d'experts (« les experts suggèrent... »).

Rappel de la source : plus la force de la recommandation est faible (avis d'experts < GRADE 2 < GRADE 1), plus une déclinaison locale argumentée et pluridisciplinaire peut s'en écarter. Ce référentiel ne traite pas de la définition de l'allergie aux bêta-lactamines, ni de la prévention de l'endocardite infectieuse (cf. recommandations européennes 2023 dédiées).

Antibioprophylaxie — Champ 1 (recommandations générales)



Délai d'administration & réinjection peropératoire

Quand administrer l'antibioprophylaxie ?		
Réf.	Recommandation	Niveau
R1.1	Il est recommandé d'administrer l'antibioprophylaxie par céphalosporine (ou ses alternatives en cas d'allergie, hors vancomycine) au plus tôt 60 minutes avant et au plus tard avant l'incision chirurgicale ou le début de la procédure interventionnelle, pour diminuer l'incidence d'ISO.	GRADE 1
R1.2	En cas d'utilisation de la vancomycine, les experts suggèrent d'en débiter l'administration intraveineuse sur 60 minutes chez le patient non obèse au plus tôt 60 minutes avant, et au plus tard 30 minutes avant l'incision ou le début de la procédure, pour diminuer l'incidence d'ISO.	AE

Argumentaire clé : une administration après l'incision est associée à un surrisque d'ISO (méta-analyse De Jonge 2017, OR 1,89 [1,05-3,40]) ; le délai optimal se situe dans les 60 minutes précédant l'incision, sans différence démontrée entre 60-30 min et 30-0 min. Une administration avant l'induction anesthésique facilite l'imputabilité d'une éventuelle réaction allergique. Pour la vancomycine, le délai optimal se situe entre 60 et 30 minutes avant l'incision (un début trop précoce ou trop tardif est associé à un surrisque d'ISO) ; dilution ≤ 5 mg/mL et antihistaminique prophylactique réduisent les effets indésirables liés à la perfusion.

Réinjection peropératoire		
Réf.	Recommandation	Niveau
R1.3.1	Il est recommandé de réadministrer une à plusieurs dose(s) peropératoire(s) d'antibioprophylaxie en cas de prolongation de la chirurgie ou de l'acte interventionnel, pour diminuer l'incidence d'ISO.	GRADE 1
R1.3.2	Il est probablement recommandé de réadministrer cette (ces) dose(s), à la moitié de la dose initiale, toutes les 2 demi-vies de l'antibiotique utilisé, pour diminuer l'incidence d'ISO.	GRADE 2

Rythme de réinjection peropératoire (posologie = moitié de la dose initiale) :

Toutes les 2 h	Toutes les 4 h	Toutes les 8 h	Pas de réinjection
Céfoxitine (1 g) Céfuroxime (0,75 g) Amoxicilline/clavulanate (1 g)	Céfazoline (1 g) Clindamycine (450 mg)	Vancomycine (10 mg/kg)	Gentamicine, métronidazole, teicoplanine (demi-vie très longue)

Réadministration également à discuter en cas de saignement peropératoire important et/ou de perfusion de grands volumes et/ou de transfusion de plusieurs CGR, même si le délai normalement prévu n'est pas atteint (avis d'experts, pas de seuil consensuel formulé en recommandation).

Antibioprophylaxie — Champ 1 (recommandations générales)



Durée & adaptation chez le patient obèse

Durée de l'antibioprophylaxie

Réf.	Recommandation	Niveau
R1.4	Il n'est pas recommandé, dans la très grande majorité des cas (et hors exceptions mentionnées dans chaque tableau disciplinaire), de prolonger l'administration de l'antibioprophylaxie au-delà de la fin de la chirurgie, pour diminuer l'incidence d'ISO.	GRADE 1

Argumentaire clé : 33 méta-analyses (2000-2022) comparant administration « courte » (peropératoire, ≤ 24 h postopératoires) vs. « prolongée » (> 24 h à 7 j) ne retrouvent, à de rares exceptions près (chirurgie cardiaque, chirurgie orthognatique — données anciennes ou contradictoires), aucune supériorité d'une administration prolongée. Quand une prolongation pourrait exceptionnellement se discuter (à ne pas confondre avec une antibiothérapie préemptive ou probabiliste), aucun argument ne justifie de dépasser 48 heures postopératoires.

Adaptation chez le patient obèse

Réf.	Recommandation	Niveau
R1.5.1	Il n'est probablement pas recommandé d'augmenter la dose unitaire de céphalosporine chez le patient obèse pour diminuer l'incidence d'ISO, en dehors de cas particuliers (notamment IMC > 50 kg/m²).	GRADE 2
R1.5.2	Les experts suggèrent de ne pas augmenter la dose unitaire d'amoxicilline-clavulanate chez le patient obèse, en dehors de cas particuliers (notamment IMC > 50 kg/m²).	AE
R1.6	Pour les alternatives aux bêta-lactamines en cas d'allergie, les experts suggèrent d'utiliser des doses adaptées à l'IMC chez le patient obèse (détail ci-dessous), pour diminuer l'incidence d'ISO.	AE

Rationnel R1.5.1/R1.5.2 : céphalosporines (céfazoline, céfoxitine, céfuroxime) et amoxicilline sont hydrophiles — leur volume de distribution n'augmente pas proportionnellement à la masse grasse. Un bolus de 2 g de céfazoline atteint la cible pharmacocinétique chez l'obèse jusqu'à la fin de la chirurgie ou 4 h après injection (données PK/PD les plus étoffées), sans bénéfice clinique démontré d'une dose supérieure (3 g) sur l'incidence d'ISO dans plusieurs cohortes. Pour la céfoxitine (2 g), les concentrations restent au-dessus de la cible jusqu'à 2 h après injection (intervalle de réinjection) ; pour le céfuroxime, les données disponibles (bolus de 1,5 g) montrent de même des concentrations satisfaisantes jusqu'à au moins 2 h.

R1.6 — doses détaillées chez le patient obèse (alternatives aux bêta-lactamines) :

Molécule	Dose chez le patient obèse
Clindamycine	900 mg pour IMC 30-45 kg/m² ; 1200 mg pour IMC 46-60 kg/m² ; 1600 mg pour IMC > 60 kg/m²
Gentamicine	6 à 7 mg/kg de poids ajusté (identique au non-obèse, calcul sur poids ajusté = poids idéal + 0,4 × [poids total – poids idéal])
Vancomycine	20 mg/kg de poids total (comme chez le non-obèse)
Teicoplanine	Non recommandée chez le patient obèse (absence de donnée dans cette population)

Antibioprophylaxie — Champ 1 (recommandations générales)

Patient colonisé à E-BLSE & traçabilité



Patient colonisé au niveau rectal à E-BLSE (chirurgie colo-rectale)

Réf.	Recommandation	Niveau
R1.7.1	Dans les centres où la prévalence de colonisation digestive à entérobactéries productrices de BLSE (E-BLSE) des patients opérés de chirurgie colorectale est $\geq 10\%$, les experts suggèrent un dépistage de la colonisation rectale à E-BLSE dans le mois précédant la chirurgie, pour adapter l'antibioprophylaxie et diminuer l'incidence d'ISO.	AE
R1.7.2	En cas de positivité du dépistage, les experts suggèrent d'administrer, pour une chirurgie colo-rectale, une antibioprophylaxie ciblée active sur la souche d'E-BLSE identifiée, pour diminuer l'incidence d'ISO.	AE
R1.7.3	Les experts suggèrent une prise en charge multidisciplinaire (anesthésiste-réanimateur, chirurgien, infectiologue ou référent en infectiologie, microbiologiste) pour individualiser l'antibioprophylaxie des patients colonisés au niveau rectal à E-BLSE en chirurgie colo-rectale.	AE

Argumentaire clé : la colonisation à E-BLSE multiplie par ~1,6 le risque d'ISO toutes bactéries confondues, et par ~7 le risque d'ISO à E-BLSE (méta-analyse Righi et al.). Chez les porteurs, une antibioprophylaxie ciblée (ertapénème 2 g IV lent en dose unique, ou alternative efficace sur la souche — céfoxitine, amoxicilline/clavulanate, pipéracilline/tazobactam) réduit l'incidence d'ISO par rapport à une antibioprophylaxie standard (étude Nutman : NNT = 13). Dans un objectif d'épargne des carbapénèmes, l'administration systématique de carbapénème n'est **pas** synonyme d'antibioprophylaxie ciblée : plusieurs alternatives actives sur certaines souches d'E-BLSE existent. Seuil de 10 % retenu par analogie avec la définition OMS d'une colonisation « élevée », en l'absence de seuil prospectivement validé.

Sources et traçabilité

Document source : « Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle adulte et pédiatrique » — Recommandations Formalisées d'Experts (RFE) de la Société Française d'Anesthésie et Réanimation (SFAR) et de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF), en association avec 32 sociétés savantes (AFU, SFR/RI, SFCR, SFO, SFSCMFCO, SFORL, ADARPEF, SOFCOT, SPLF, SFCTCV, SFC, CNGOF, SCVE, SFNC, SFB, SOFCPRE, SFED, SFCD, ACHBT, CARO, GPIP, SFOP, SOFOP, SFCP, SFCPP, SFUPA, AFOP, GFHFNP, SFNCP, SFN, et autres). Coordonnateurs : Marc Leone (SFAR, Marseille), Mathilde de Queiroz (SFAR, Lyon, partie pédiatrique), Rémy Gauzit (SPILF, Paris). Organismes : Marc Garnier (Clermont-Ferrand), Maxime Nguyen (Dijon, partie pédiatrique).

Validation : Champs 1-2 (introduction, recommandations générales, tableaux adultes) — CRC SFAR 15/06/2023, CA SFAR 30/06/2023, comité des référentiels SPILF 06/09/2023, puis conseils d'administration des sociétés associées entre septembre et décembre 2023 (validation tacite au 30/11/2023 pour les autres). Champ 3 (tableaux pédiatriques) — CRC SFAR 26/03/2026, CA SFAR 20/05/2026, SPILF 02/03/2026, GPIP 27/01/2026, puis conseils d'administration des sociétés pédiatriques associées entre décembre 2025 et mars 2026.

Historique des versions : V1.0 (08/12/2023, version originale) ; V1.1-V2.0 (déc. 2023 - mai 2024, corrections de coquilles et clarifications dans les tableaux disciplinaires) ; **V3.0 (04/05/2026)** — ajout de la recommandation R1.5.2 (dose d'amoxicilline-clavulanate chez l'obèse), clarification de R1.6, et ajout du Champ 3 (9 tableaux pédiatriques et néonataux) ; V3.1 (10/07/2026) — amendement d'un schéma de chirurgie digestive néonatale. Cette fiche reflète la V3.0/V3.1.

Méthodologie : méthode GRADE® — recherche bibliographique MEDLINE/Cochrane/clinicaltrials.gov (janvier 2000 - mars 2023), méthodologie PRISMA, cotation GRADE Grid par les experts (accord retenu à $\geq 70\%$ d'opinions convergentes et $< 20\%$ d'opinions contraires ; avis d'experts systématiquement soumis au même seuil de 70 %). Les 11 recommandations du Champ 1 ont toutes obtenu un accord fort.

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des **11 recommandations du Champ 1** (recommandations générales) — délai d'administration, réinjection peropératoire, durée, adaptation chez l'obèse, patient colonisé à E-BLSE — avec leur argumentaire clé. Elle **exclut explicitement** les Champs 2 et 3 (18 tableaux disciplinaires adultes et pédiatriques de posologie par procédure, ~85 pages) : voir le panneau de périmètre en page 1 et se référer au texte intégral pour le choix et la dose de l'antibioprophylaxie d'une procédure donnée.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire, limitée au Champ 1 (recommandations générales) de la RFE SFAR/SPILF 2024 (V3.0 du 04/05/2026). Elle ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques, tableaux disciplinaires des Champs 2-3) et n'est ni éditée ni validée par la SFAR, la SPILF ou les sociétés savantes associées. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé (infectiologue, référent antibiothérapie).